

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

FACULDADE DE MEDICINA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE:

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

**Qualidade de vida em mulheres doadoras e receptoras de oócitos submetidas à
fertilização *in vitro***

Camila Oliveira de Souza

PORTO ALEGRE - RS

2026

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

FACULDADE DE MEDICINA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE:

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

**Qualidade de vida em mulheres doadoras e receptoras de oócitos submetidas à
fertilização *in vitro***

Camila Oliveira de Souza

Orientador: João Sabino Lahorgue da Cunha Filho

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação
em Ciências da Saúde: Ginecologia e Obstetrícia da
Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul como requisito parcial para a obtenção do
título de mestre em Ginecologia e Obstetrícia.

PORTO ALEGRE - RS

2026

CIP - Catalogação na Publicação

de Souza, Camila Oliveira
Qualidade de vida em mulheres doadoras e receptoras
de óócitos submetidas à fertilização in vitro / Camila
Oliveira de Souza. -- 2026.
43 f.
Orientador: João Sabino Lahorgue da Cunha Filho.

Dissertação (Mestrado) -- Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, Faculdade de Medicina, Programa de
Pós-Graduação em Ciências da Saúde: Ginecologia e
Obstetrícia, Porto Alegre, BR-RS, 2026.

1. qualidade de vida. 2. ovodação. 3. ovorecepção
. 4. Fertilização in vitro. 5. infertilidade. I.
Lahorgue da Cunha Filho, João Sabino, orient. II.
Título.

CAMILA OLIVEIRA DE SOUZA

Qualidade de vida em mulheres doadoras e receptoras de oócitos submetidas à fertilização *in vitro*

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde: Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para a obtenção do título de mestre em Ginecologia e Obstetrícia.

Aprovado em: 27/02/2026.

BANCA EXAMINADORA

ANDREA PIRES SOUTO DAMIN
UFRGS

CARLOS AUGUSTO BASTOS DE SOUZA
INSEMINÉ

DANIELA VANESSA VETTORI
UFRGS

Agradecimentos

Conquistar algo sozinho é apenas uma conquista. Compartilhar as conquistas com quem te dá apoio é uma vitória.

Agradeço imensamente aos meus pais, Solange e Marco, pelo incentivo para que eu tivesse um caminho próspero nos estudos e por acreditarem em mim. Vocês são a minha base mais sólida, que me ensinaram sempre sobre força e carinho.

Às minhas irmãs, que são as minhas fontes de inspiração. Fernanda, sempre presente e meu exemplo de disciplina. Tatiane, meu exemplo de cuidado e de profissional, que me apresentou os caminhos da reprodução assistida. Muito obrigada!

Agradeço e dedico esse trabalho aos meus sobrinhos/afilhados, Maria Antônia, Rafael e Helena, que são meus presentes da vida. Assistir à caminhada e ao crescimento de vocês enche meu coração de orgulho e de amor.

Agradeço muito também aos meus cunhados e demais familiares pelo apoio e suporte sempre que necessário.

Não posso deixar de agradecer aos meus amigos, que, muitas vezes, notaram minha ausência em função dessa etapa da vida, mas, mesmo assim, sempre estiveram ao meu lado. Eu tenho muita sorte de ter amizades de infância e de amizades mais recentes, que são um pilar essencial na minha jornada de vida.

E ao Dr. João Sabino, meu orientador, muito obrigada pela paciência nos momentos de maior dificuldade no trabalho e pelo aprendizado. Aprender com quem ama o que faz fica muito mais leve.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ANOVA - Análise de variância

CFM - Conselho federal de medicina

FERTIQOL - Fertility Quality of life

FIV - Fertilização in vitro

IA - Inseminação artificial

JASP - Jeffreys's Amazing Statistics Program

OMS - Organização Mundial de Saúde

QV - Qualidade de vida

SOP - Síndrome dos ovários policísticos

TCLE - Termo de consentimento livre e esclarecido

Lista de figuras

Figura 1 - Mapa conceitual esquemático

Lista de tabelas

Artigo:

Table 1. Demographic characteristics

Table 2. Histórico de gestações e tratamentos

Table 3. Resultados FERTIQOL nos grupos

Table 4. Histórico de cuidados em saúde mental

RESUMO

Introdução: Ter filhos é o projeto de vida de muitos casais, porém esse sonho pode ser afetado em função da infertilidade, que ocorre em cerca de 15% das pessoas a nível mundial. Diante desse número elevado, os tratamentos de reprodução assistida ganharam notoriedade e passaram a ser uma alternativa para muitos indivíduos. Além disso, com os avanços da medicina, a doação de oócitos também teve um aumento significativo, o que pode causar impacto emocional tanto nas doadoras quanto nas receptoras de óvulos, acarretando diminuição da qualidade de vida (QV) dessas mulheres. **Objetivo:** Esta pesquisa tem como objetivo verificar a qualidade de vida das mulheres doadoras, receptoras de óvulos, bem como de mulheres inférteis que farão tratamento de reprodução assistida, porém não serão doadoras ou receptoras. **Método:** Estudo transversal prospectivo, no qual foram aplicados o questionário FERTIQOL para avaliar QV e um questionário sociodemográfico a 60 mulheres em tratamento em uma clínica de reprodução assistida na cidade de Porto Alegre - RS. **Resultado:** De acordo com os dados coletados, foi observada diferença significativa no resultado do fertiqol total ($p < 0,001$). Nos domínios que o instrumento abrange, os resultados também foram significativos: domínio mente e corpo ($p < 0,001$); emocional ($p < 0,001$); relacional ($p = 0,040$); e social ($p = 0,018$). As 26 mulheres em tratamento sem doar ou receber óvulos apresentaram níveis mais baixos de qualidade de vida, considerando Fertiqol total e todos os domínios apresentados, comparadas às 15 receptoras e 19 doadoras. **Conclusão:** Mulheres em tratamento de reprodução assistida apresentam sofrimento emocional durante o tratamento, resultando na diminuição da qualidade de vida, quando comparadas às mulheres que realizam o processo de ovodação durante o tratamento.

PALAVRAS-CHAVE

Qualidade de vida; ovodação; ovorecepção; infertilidade; fertilização in vitro.

ABSTRACT

Abstract

Introduction: Having children is the life project of many couples, but this dream can be affected by infertility, which affects about 15% of people worldwide. Given this high prevalence, assisted reproduction treatments have gained notoriety and have become an alternative for many individuals. Furthermore, advances in medicine have significantly increased oocyte donation, which can have a profound emotional impact on both egg donors and recipients, potentially decreasing the quality of life (QoL) of these women. **Objective:** This study aims to assess the quality of life of female egg donors and recipients, as well as infertile women who will undergo assisted reproduction treatment but will not be donors or recipients. **Method:** Prospective cross-sectional study in which the FERTIQOL questionnaire was used to assess QoL and a sociodemographic questionnaire was administered to 60 women undergoing treatment at an assisted reproduction clinic in Porto Alegre, Rio Grande do Sul. **Result:** According to the collected data, a significant difference was observed in the total FERTIQOL score ($p < 0.001$). In the domains covered by the instrument, the results were also significant, with mind and body $p < 0.001$, emotional $p < 0.001$, relational $p = 0.040$, and social $p = 0.018$. The 26 women undergoing treatment without donating or receiving eggs had lower quality-of-life scores, as measured by FERTIQOL total and all domains, compared to the 15 recipients and 19 donors. **Conclusion:** Women undergoing assisted reproductive treatment experience emotional distress during the treatment, resulting in a reduced quality of life when compared with women who undergo the oocyte donation process during treatment.

KEYWORDS

Quality of life; egg donation; egg reception; infertility; in vitro fertilization.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	10
2. REVISÃO SISTEMATIZADA DA LITERATURA	11
2.1 QUALIDADE DE VIDA	12
2.2 INFERTILIDADE	13
2.3 OVODOAÇÃO	14
3. JUSTIFICATIVA	17
4. HIPÓTESE	18
5. OBJETIVOS	18
6. REFERÊNCIAS	19
7. Article	22
8. CONSIDERAÇÕES FINAIS	38
9. PERSPECTIVA	39
10. ANEXOS	40
10.1 ANEXO 1 - Termo de consentimento livre e esclarecido	40
10.2 ANEXO 2 - FERTIQOL	42
10.3 ANEXO 3 - Questionário sociodemográfico	43

1. INTRODUÇÃO

Para muitas mulheres, a maternidade inicia-se muito antes da idade adulta e gestar faz parte de um desejo que, muitas vezes, advém da infância (Quadro, 2021). No entanto, a infertilidade atinge aproximadamente de 10 (dez) a 15 (quinze) por cento dos casais em idade reprodutiva (Angel et al, 2014) e já é considerada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) um problema de saúde pública, afetando milhões de pessoas em idade reprodutiva no mundo (OMS, 2020). É caracterizada pela impossibilidade de gestar em até 12 (doze) meses de práticas sexuais para mulheres de até 35 (trinta e cinco) anos, sem uso de contraceptivos (Jing et al, 2021).

As causas da infertilidade são variadas, sendo alguns predispositores já de conhecimento público, como endometriose, síndrome dos ovários policísticos (SOP), fatores tubários, hormonais, a própria falência ovariana — que pode também estar associada ao desejo de postergar a decisão de ter filhos —, além de fatores masculinos. Com a evolução da medicina, atualmente existem tratamentos de reprodução assistida que podem auxiliar casais inférteis, como a inseminação artificial (IA) e a fertilização in vitro (FIV) (OMS, 2020).

Para muitas pessoas, ter um filho é o maior projeto de vida e, quando isso não ocorre, pode acarretar prejuízos psicossociais. Ter filhos, na atualidade, ainda constitui um ideal de felicidade para muitos homens e mulheres. A infertilidade pode trazer sentimentos relacionados à impotência e à frustração, fazendo com que o desejo de ser mãe tende a se tornar um momento de aumento importante de estresse. O processo percorrido pelos casais tentantes não tem tempo definido, é permeado por diversos exames para identificar a causa da infertilidade e não há um limite de tratamentos (Lourenço, 2020). Com isso, esses casais podem apresentar ansiedade, bem como dificuldades na vida laboral e social, o que pode ser notado através da qualidade de vida (Song et al, 2021).

O estresse individual do tratamento acarreta sofrimento psicossocial, muitas vezes resultando em aumento da ansiedade e em impacto negativo na relação conjugal (LoGiudice, Massaro, 2018). Casais inférteis se defrontam com a realidade de não poderem dar sequência à própria existência, o que ocasiona efeitos adversos na vida do indivíduo e do casal. Esses efeitos podem causar um declínio na qualidade de vida (Marciano et al 2024).

A qualidade de vida (QV) é um conceito complexo, de difícil conceituação e que muitas vezes se associa à saúde. De acordo com Palomba et al. (2018), é definido como a

forma como cada indivíduo se percebe no seu contexto de vida, abrangendo a cultura, os valores de cada um e o ambiente. Ademais, a QV estaria também relacionada a expectativas de cada indivíduo (Pereira et al, 2012). De acordo com a OMS, o conceito de qualidade de vida é “a percepção do indivíduo de sua inserção na vida, no contexto da cultura e dos sistemas de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações”.

2. REVISÃO SISTEMATIZADA DA LITERATURA

Com o intuito de sustentar o estudo, foram utilizadas as bases de dados PubMed, Embase, Web of Science e Lilacs para a busca de artigos científicos. As palavras-chave utilizadas para a realização da busca foram: qualidade de vida, infertilidade, doação de oócitos, fertilização in vitro e suas variações na língua inglesa.

A partir da pesquisa realizada, com base nos descritores citados, foram encontrados 149 artigos na base de dados PUBMED, 296 publicações na EMBASE, 25 na Web of Science e 5 artigos na base de dados Lilacs. Desses artigos ,foram excluídos os que apresentaram duplicidade e não apresentaram dados significativos para essa pesquisa.

Figura 1 - Mapa conceitual esquemático

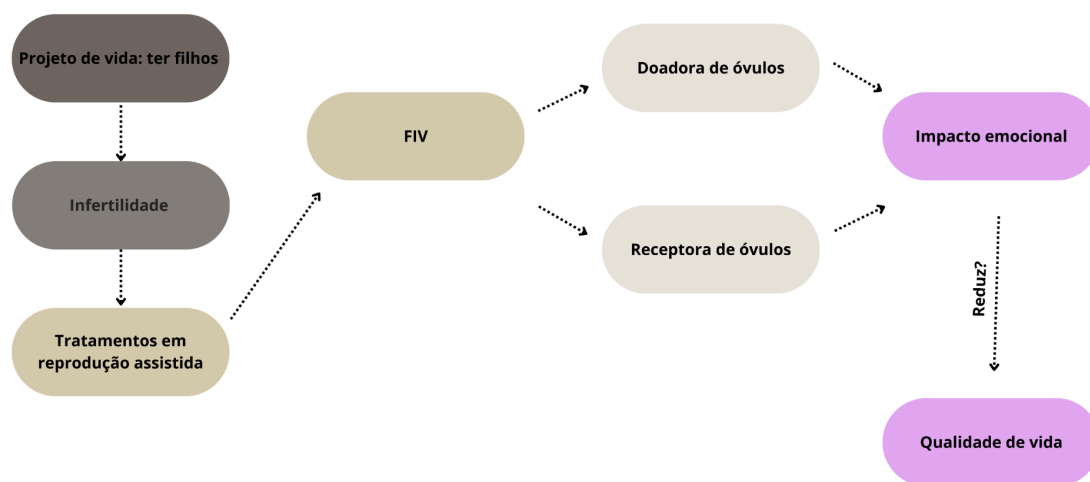


Figura 1. Mapa conceitual esquemático com os conceitos que descrevem e caracterizam a pesquisa.

2.1 QUALIDADE DE VIDA

Qualidade de vida (QV) é um conceito complexo que abrange aspectos de saúde física e psicológica, bem como sociais e ambientais. Demonstra ainda ser uma questão subjetiva, ampla e de difícil mensuração (Palomba et al, 2018).

Ao longo dos anos, vários questionários de qualidade de vida relacionados à saúde foram validados. O FertiQOL é um instrumento que avalia qualidade de vida com viés da fertilidade, justamente visando casais com tal prejuízo (Donarelli et. al, 2016).

Atualmente, é uma ferramenta amplamente utilizada para avaliar a qualidade de vida associada à fertilidade. O instrumento contém 24 (vinte e quatro) questões e os resultados abrangem 4 (quatro) domínios: mente e corpo, medindo o impacto na saúde física e cognitiva; emocional, a fim de analisar até que ponto a infertilidade causa tristeza e ansiedade; relacional, compreendendo se a infertilidade prejudica a conjugalidade; e social, buscando verificar se o indivíduo apresenta prejuízo em sua vida social e em sua rede de

apoio. A infertilidade e os tratamentos de reprodução assistida têm um impacto direto no bem-estar dos pacientes e uma resposta emocional negativa (Madero et al, 2017).

Conforme Jing et al (2021), mulheres inférteis carregam um estigma, visto que ainda ocorre uma pressão social associada à procriação, acarretando culpa pela não efetivação da gestação. Outrossim, de acordo com Wdowiak et al (2021), as críticas relacionadas ao não engravidar são direcionadas às mulheres. De acordo com esse mesmo autor, estudos demonstram que a infertilidade pode reduzir a qualidade de vida de casais inférteis.

2.2 INFERTILIDADE

A infertilidade pode ser definida como a dificuldade de obter e/ou manter a gestação. Aliás, existem duas diferentes categorizações de infertilidade, classificadas como primária e secundária. A infertilidade primária é caracterizada por um casal que não conseguiu conceber desde a primeira tentativa. Já a secundária é quando o casal já teve uma gestação, independentemente do desfecho, e não consegue engravidar novamente (Hayashi e Moriyama, 2019).

Em 1978, com o nascimento do primeiro bebê por fertilização in vitro, novas perspectivas se abrem para esses casais que, muitas vezes, se viam sem esperança. A infertilidade é um tema tabu, fazendo com que os casais tenham grande dificuldade de expor o que estão vivenciando (Awtani et al, 2019).

Além disso, a questão da infertilidade pode gerar diversos sentimentos em quem recebe o diagnóstico, como culpa e vergonha. Esse diagnóstico pode acarretar o isolamento social, bem como sentimentos de inferioridade, desencadeando quadros de ansiedade e depressão (Marciano et al 2024).

Ainda em função do tratamento de fertilização in vitro, as mulheres podem vir a apresentar, além das emoções já citadas, como ansiedade e estresse, problemas relacionados à autoestima, dificuldade de relacionamento com o parceiro e com os demais, podendo ocasionar isolamento social (Wojciechowska; Milska-Musa, 2024).

Alguns estudos evidenciam diferenças no enfrentamento da infertilidade e no tratamento entre homens e mulheres. De acordo com Yi-Ling Hsu et al. (2002), as esposas

despendem mais energia e tempo com os tratamentos de reprodução assistida, e por isso sentem mais exigidas durante o tratamento (Awtani et al., 2019). Também apresentam maior índice de ansiedade e depressão em comparação com seus parceiros.

Durante o período de tratamento, os casais precisam tomar uma série de decisões difíceis, reiterando que possivelmente a decisão mais difícil se dá no momento da falha do tratamento, quando o casal precisa se reorganizar financeiramente e emocionalmente (Chan et al 2016).

Os problemas de fertilização trazem prejuízos físicos e emocionais aos casais, envolvendo períodos de exames para a investigação de infertilidade e o próprio tratamento. Esse período é marcado por inseguranças e uma série de incertezas (Song et al, 2021).

De acordo com Jing (2021), há diferentes tratamentos de reprodução assistida que podem ser utilizados, dependendo da causa da infertilidade. Um dos tratamentos utilizados é a fertilização in vitro (FIV).

A FIV apresenta um desenvolvimento tecnológico significativo desde o primeiro bebê em 1978. Com tais mudanças, os tratamentos de reprodução assistida foram sendo cada vez mais estudados e pesquisados, ganhando notoriedade em razão de seus resultados. A fertilização in vitro possibilita hoje que a gestação ocorra em mulheres de maneira solo, em casais homoafetivos e em casais inférteis, inclusive a partir da doação de espermatozoides ou óvulos. O ciclo da FIV, que geralmente dura aproximadamente 15 (quinze) dias, tem início com a estimulação ovariana, passa pela aspiração dos folículos e termina com a transferência do embrião (Eskew & Jungheim, 2017).

2.3 OVODOAÇÃO

Uma das formas de realização da FIV envolve óvulos doados. O compartilhamento anônimo de óvulos é geralmente realizado por mulheres em tratamento com FIV, que, assim, poderão doar parte de seus óvulos. Cada país tem sua norma para a doação (Asplund, 2020).

No Brasil, o Conselho Federal de Medicina (CFM) é o órgão responsável por regulamentar as técnicas de reprodução assistida. De acordo com a Resolução CFM nº 2.320/2022, a doação de gametas é permitida sem que haja fins lucrativos ou comercialização

e deve ser realizada de forma sigilosa tanto para a doadora quanto para a receptora. O único momento em que o anonimato não ocorre é na doação familiar, quando a receptora poderá receber oócitos de familiar com parentesco de até 4º grau. A ovodoação poderá ser realizada por mulheres de até 37 (trinta e sete) anos. Ainda, de acordo com o CFM, a doação de gametas pode ser realizada voluntariamente ou por meio de doação compartilhada. Na segunda opção, doadora e receptora compartilharão do material biológico e dos custos envolvidos (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2022).

Os aspectos legais relativos à doação de gametas variam de país para país. No Reino Unido, por exemplo, é permitido o contato com a doadora após atingir a maioridade, o que oferece a oportunidade de reconhecer sua história genética. Essa possibilidade suscita preocupação com o vínculo e medo de rejeição por parte da receptora. Diante desse contexto, nos países em que a doação é anônima, a maioria relata sentir maior tranquilidade (Bracewell-Milnes, 2016).

Um estudo realizado em Taiwan, país muito reconhecido pelos tratamentos de reprodução assistida do continente asiático, aborda o incentivo às mulheres doadoras de óvulos, o que promove o altruísmo. Apesar de não poder ser comercializado, o incentivo financeiro é altamente atrativo, levando as doadoras a receber cerca de 3 mil dólares por ciclo. Mesmo com tal incentivo, as doadoras relatam que a principal motivação é o desejo de ajudar outras mulheres (Chen, 2025).

No que se refere à escolha entre uma doadora anônima ou uma conhecida, alguns estudos apontam que a doação anônima oferece maior segurança, permitindo que as mulheres estabeleçam limites mais definidos entre as partes envolvidas (Bracewell-Milnes, 2016).

Referente à doação de oócitos, diante do viés psicológico, há diferentes motivações, como o altruísmo, a contribuição científica e questões financeiras. De acordo com um estudo sueco, o altruísmo predomina nessa tomada de decisão, mas, assim, traz um sentimento ambivalente à doadora (Svanberg, Lampic & Gejervall, 2012).

Outra questão que faz com que as doadoras de óvulos hesitem em sua decisão é a própria natureza do tratamento, que demanda procedimentos invasivos, além do uso de hormônios, o que traz sobrecarga e desgaste, tanto físicos quanto emocionais (Bracewell-Milnes, 2016).

Outro estudo realizado com o objetivo de verificar a aceitação da doação de oócitos, ovorecepção e adoção de crianças por mulheres inférteis submetidas a tratamento de reprodução assistida demonstra que quase metade das mulheres não doaria seus oócitos por não querer que outra mulher carregue sua carga genética (Straehl et al, 2017).

Já um estudo realizado no Irã identificou que, apesar do crescimento do número de tratamentos por ovodoação e do sucesso terapêutico observado com esses procedimentos, o uso de oócitos doados pode acarretar desafios aos casais, como o risco de transmissão de doenças hereditárias, além de questões religiosas, legais e culturais (Ghelich-khani et al. 2020).

Em contrapartida, uma revisão sistemática realizada em 2016 mostrou que as doadoras que compartilham seus óvulos têm o desejo de auxiliar outros casais, preocupando-se com bons resultados e querendo trazer a felicidade para o outro (Bracewell-Milnes et al, 2016).

O número de casais que buscam tratamentos de reprodução humana vem crescendo em função do aumento da longevidade e dos casamentos tardios. Outro fator que faz com que os casais busquem por tratamento tardiamente se dá em função da inserção da mulher no mercado de trabalho de forma efetiva (Urata et al, 2024)

Sabe-se que a idade da mulher é o fator prognóstico mais determinante para a gestação. Dessa forma, mulheres após os 40 anos de idade normalmente apresentam uma reserva ovariana diminuída e uma qualidade oocitária menor — o que reduz significativamente a chance dessa mulher de engravidar e aumenta as taxas de abortamento nessa faixa etária. Uma alternativa para mulheres que possuem uma reserva ovariana muito reduzida ou que, até mesmo, já se encontram no período da menopausa é a fertilização in vitro com óvulos doados (ovodoação).

A doação de oócitos teve um crescimento em nível mundial, possibilitando que gestações possam ocorrer, inclusive, em mulheres inférteis em função da idade/falência ovariana (Martinez et al, 2021). Também pode ser uma opção quando há anomalias genéticas com possível transmissão, falha em repetidas FIVs e dificuldade de responder à estimulação ovariana (Straehl et al, 2017).

De acordo com Ghelich-Khani et al (2020), casais que se submetem a tratamento com óvulos doados esperam um tratamento especializado, de alta qualidade e com atenção especial à sua saúde mental.

Um estudo sobre representação materna, realizado no Sul do Brasil, avaliou gestantes que receberam tratamentos de reprodução assistida com óvulos doados. Foi identificado que, durante a gestação, a mulher sente-se insegura quanto à formação do bebê, justamente devido ao desconhecimento das informações genéticas da doadora. A insegurança também se faz presente entre as gestantes quando se fala sobre as características físicas do bebê (Schneider & Schneider Donelli, 2019).

Essas mulheres em tratamento de fertilização in vitro e durante a gestação encontram-se em um momento de vulnerabilidade aumentada, muitas vezes fragilizadas emocionalmente, apresentando sintomas de ansiedade e, por vezes, depressão. Para que possam lidar de uma forma mais saudável com as demandas do tratamento, é necessário o acompanhamento de uma equipe em saúde mental, reforçando a importância de realizar psicoterapia nesse momento de maior desgaste (Gameiro et al, 2015).

3. JUSTIFICATIVA

Por meio dessa pesquisa, buscou-se compreender questões relacionadas à qualidade de vida dessas mulheres tentantes, pois, na prática clínica, podemos perceber possíveis prejuízos emocionais. Além disso, sabe-se que a possibilidade de doação e de recepção de óvulos também pode acarretar maior fragilidade emocional. Verifica-se a existência de muitos estudos sobre a doação e a recepção de óvulos, sob o ponto de vista legal e médico. Porém, poucos exploram os impactos emocionais de uma doação de óvulos e, principalmente, de quem a recebe.

Com o intuito de elaborar diferentes abordagens que minimizem o sofrimento psíquico que permeia tal vivência, esse estudo teve como objetivo compreender a qualidade de vida de mulheres doadoras e receptoras de oócitos, bem como de mulheres inférteis, não doadoras ou receptoras.

4. HIPÓTESE

A infertilidade causa prejuízo à qualidade de vida das mulheres que realizam tratamento de fertilização in vitro com ovodoação (doadoras e receptoras).

Hipótese nula

A infertilidade não causa prejuízo à qualidade de vida das mulheres que realizam tratamento de fertilização in vitro com ovodoação (doadoras e receptoras).

5. OBJETIVOS

Principal

Verificar se há diferença na qualidade de vida de mulheres inférteis que vão realizar doação de óvulos, que serão receptoras, e as que estão realizando tratamento, sem doar ou receber óvulos, utilizando os resultados alcançados através do instrumento FERTIQOL.

Secundário

Identificar se há correlação entre qualidade de vida e fatores sociodemográficos, como escolaridade, estado civil, filhos anteriores, além de relacionar com os 4 domínios apresentados pelo questionário FERTIQOL: mente-corpo, emocional, relacional e social.

6. REFERÊNCIAS

Angel M, **et al.** A randomized trial comparing the ovulation induction efficacy of clomiphene citrate and letrozole. *J Nat Sci Biol Med* 2014;5:450–452.

Asplund K. Use of in vitro fertilization—ethical issues. *Ups J Med Sci* 2020;125:192–199. <https://doi.org/10.1080/03009734.2019.1684405>

Boivin J, Griffiths E, Venetis CA. Emotional distress in infertile women and failure of assisted reproductive technologies: meta-analysis of prospective psychosocial studies. *BMJ* 2011;342:d223.

Bracewell-Milnes T, Saso S, Bora S, Ismail AM, Al-Memar M, Hamed AH, **et al.** Investigating psychosocial attitudes, motivations and experiences of oocyte donors, recipients and egg sharers: a systematic review. *Hum Reprod Update* 2016;22:450–465. <https://doi.org/10.1093/humupd/dmw006>

Chan CHY, Lau HPB, Tam MYJ, Ng EHY. A longitudinal study investigating the role of decisional conflicts and regret and short-term psychological adjustment after IVF treatment failure. *Hum Reprod* 2016;31:2772–2780. <https://doi.org/10.1093/humrep/dew233>

Conselho Federal de Medicina (CFM). Resolução CFM nº 2.320/2022. Brasília: CFM; 2022.

Donarelli Z, Lo Coco G, Gullo S, Salerno L, Marino A, Sammartano F, Allegra A. The Fertility Quality of Life Questionnaire (FertiQoL) relational subscale: psychometric properties and discriminant validity across gender. *Hum Reprod* 2016;31:2061–2071. <https://doi.org/10.1093/humrep/dew168>

Eskew AM, Jungheim ES. A history of developments to improve in vitro fertilization. *Mo Med* 2017;114:156–159.

Gameiro S, Boivin J, Dancet E, de Klerk C, Emery M, Lewis-Jones C, **et al.** ESHRE guideline: routine psychosocial care in infertility and medically assisted reproduction—a guide for fertility staff. *Hum Reprod* 2015;30:2476–2485. <https://doi.org/10.1093/humrep/dev177>

Ghelich-Khani S, Kazemi A, Fereidooni-Moghadam M, Alavi M. A mental health program for infertile couples undergoing oocyte donation: protocol for a mixed methods study. *Reprod Health* 2020;17:12.

Hayashi EAP, Moriyama JDS. Grupo de apoio psicológico a mulheres em situação de infertilidade. *Psicol Cienc Prof* 2019;39:e179820.

World Health Organization. Infertility. Geneva: WHO; 2020.

Jing X, Gu W, Zhang L, **et al.** Coping strategies mediate the association between stigma and fertility quality of life in infertile women undergoing in vitro fertilization–embryo transfer. *BMC Womens Health* 2021;21:386. <https://doi.org/10.1186/s12905-021-01525-9>

Julious SA. Sample sizes for clinical trials with normal data. *Stat Med* 2004;23:1921–1986.

Chen J. ‘Spreading love’ or ‘working holiday’? The narrative of altruistic rhetorics, financial motivations, and risks in domestic and transnational Taiwanese egg donation. *Soc Sci Med* 2025;384:118520. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2025.118520>

LoGiudice JA, Massaro J. The impact of complementary therapies on psychosocial factors in women undergoing in vitro fertilization: a systematic literature review. *Appl Nurs Res* 2018;39:220–228.

Lourenço GV. Percepção da infertilidade, qualidade de vida e depressão em mulheres em tratamento para reprodução assistida. Dissertação. Brasil; 2020.

Madero S, Gameiro S, García D, Cirera D, Vassena R, Rodríguez A. Quality of life, anxiety and depression of German, Italian and French couples undergoing cross-border oocyte donation in Spain. *Hum Reprod* 2017;32:1862–1870. <https://doi.org/10.1093/humrep/dex247>

Malta M, **et al.** Iniciativa STROBE: subsídios para a comunicação de estudos observacionais. *Rev Saude Publica* 2010;44:559–565.

Marciano RP, Damaceno NS, Amaral WND. Representações sociais sobre maternidade na reprodução humana assistida: discursos de mulheres inférteis. *Psicol Cienc Prof* 2024;44:e258946.

Martinez F, Racca A, Rodríguez I, Polyzos NP. Ovarian stimulation for oocyte donation: a systematic review and meta-analysis. *Hum Reprod Update* 2021;27:673–696. <https://doi.org/10.1093/humupd/dmab008>

Palomba S, Daolio J, Romeo S, **et al.** Lifestyle and fertility: the influence of stress and quality of life on female fertility. *Reprod Biol Endocrinol* 2018;16:113.

Pereira EF, Teixeira CS, Santos A. Qualidade de vida: abordagens, conceitos e avaliação. *Rev Bras Educ Fis Esporte* 2012;26:241–250.

Pocock SJ. *Clinical Trials: A Practical Approach*. Chichester: Wiley; 1983.

Schneider IE, Schneider Donelli TM. Representações maternas de gestantes sobre o bebê concebido por ovodação. *Psicol Clin* 2019;31:439–460.

Song D, Li X, Yang M, **et al.** Fertility quality of life (FertiQoL) among Chinese women undergoing frozen embryo transfer. *BMC Womens Health* 2021;21:177.

Straehl J, Lara LADS, Sá MFS, Reis RM, Rosa-e-Silva ACJS. What do infertile women think about oocyte reception, oocyte donation, and child adoption? *Rev Bras Ginecol Obstet* 2017;39:282–287. <https://doi.org/10.1055/s-0037-1603742>

Urata Y, Harada M, Komiya S, **et al.** Lifestyle and fertility-specific quality of life affect reproductive outcomes in couples undergoing in vitro fertilization. *Front Endocrinol* 2024;15:1346084. <https://doi.org/10.3389/fendo.2024.1346084>

Hsu YL, Kuo BJ. Evaluations of emotional reactions and coping behaviors as well as correlated factors for infertile couples receiving assisted reproductive technologies. *J Nurs Res* 2002;10:291–302.

7. Article

Quality of life in women who donate and receive oocytes undergoing *in vitro* fertilisation

Souza, C. O. (0000-0002-6901-8343); Cunha-filho, J. S. (0000-0002-0535-8963)

Running title:

Quality of life and egg donation

.

Abstract

Objective: This study aims to assess the quality of life of female egg donors and recipients, as well as infertile women who will undergo assisted reproduction treatment but will not be donors or recipients.

Method: A prospective cross-sectional study was administered to 60 women undergoing treatment at a private human reproduction centre. Patients were divided into 3 groups: egg recipients (n=15), egg donors (n=19) and the IVF group using their own eggs (n=26). Demographic variables, as well as reproductive and psychosocial characteristics of the included patients, were evaluated, along with the different domains assessed using FERTIQOL.

Result: Age (mean±SD) differed among the groups; donor oocytes were younger (30±3) than recipients (41±5) or regular IVF patients (36±4), $p<0.001$. Other clinical and demographic variables were similar across all included patients, except for obstetric history. Moreover, the collected data showed a significant difference in the total FERTIQOL score ($p<0.001$). In the domains covered by the instrument, the results were also significant, with mind and body $p<0.001$, emotional $p<0.001$, relational $p=0.040$, and social $p=0.018$. The 26 women undergoing regular IVF treatment without donating or receiving eggs had lower quality-of-life scores across FERTIQOL total and all domains, compared with the 15 recipients and 19 donors. Furthermore, a multivariable analysis demonstrated that, controlling for the type of infertility treatment, psychotropic medication, attempt time, and age, only the IVF group (regular IVF) was associated with a significant decrease across all FERTIQOL domains (OR 17; 95% CI 3-98).

Conclusion: Women undergoing assisted reproductive treatment, using their own eggs, experienced emotional distress during treatment, resulting in a decrease in quality of life.

KEYWORDS

Quality of life; egg donation; egg reception; infertility; in vitro fertilisation.

Introduction

The inability to conceive causes feelings of stress for most women who experience infertility. According to the World Health Organisation (WHO), one in six people will be affected by infertility during their adult lives, representing around 17.5% of the population. A couple is considered infertile if, after 12 months of trying without using contraception, they are unable to conceive when the woman is up to 35 years old.

Reproductive failure has significant consequences for these women, especially because, in many cultures, motherhood still represents a status symbol both within the family and in society. Failure to achieve this goal causes couples to suffer emotional and social damage, often leading to isolationism (Cosineau; Domar, 2007).

The difficulties faced in this context of infertility can often interfere with the quality of life of these couples. Quality of life is a broad concept which, according to the WHO, is “an individual’s perception of their position in life in the context of the culture and value systems in which they live, and in relation to their goals, expectations, standards, and concerns” (WHO, 1995), encompassing physical, psychological, social, and environmental aspects.

The obstacle of infertility causes many couples to become preoccupied with fertility issues, making this the central focus of their married life and neglecting other important aspects of life (Cosineau; Domar, 2007). According to Celda-Bélichon et al (2025), infertile couples experience different repercussions on their quality of life. While men are more affected in terms of their relationship with their partners, women suffer greater emotional, physical, and social damage. Furthermore, women also show higher rates of depressive symptoms during the treatment period.

A study conducted in Spain with couples from Germany, France, and Italy assessed the quality of life and anxiety levels of couples who travelled to the country to undergo IVF with donated eggs. The findings showed that results differ by country of origin, with France having the lowest quality of life. It was also observed that women have a lower quality of life and greater anxiety than men (Madero et al., 2017).

Due to technological advances in assisted reproduction, such as in vitro fertilisation, infertile couples now have greater hope in their desire to have children (Moutzouroulia et al, 2025). In addition, oocyte donation has become a new treatment modality for several couples seeking to have a child (Montagnini, 2012). However, even with the increase in this type of treatment, the literature remains scarce on emotional aspects and quality of life, particularly among donors and recipients.

Oocyte donation is regulated by the Federal Council of Medicine (FCM) in Brazil and permits shared gamete donation, primarily with anonymity. In this format, the donor and recipient share the biological material and the financial costs of assisted reproduction treatment. It is important to emphasise that in this treatment modality, both the donor (male infertility) and the recipient (usually a decreased ovarian reserve) present some limitations to spontaneous conception and understand that treatment through donation or reception is the best way to achieve pregnancy (Oppenheimer et al., 2018).

Generally, recipients have already come a long way from the diagnosis of infertility to the recommendation of IVF with donated eggs. Throughout this process, feelings range from frustration and fear to anguish and hope. When women accept treatment with donated eggs, their expectations increase, as they understand that donation improves their chances of pregnancy (Trindade et al., 2025).

Therefore, we described a prospective observational study that included donors, recipients, and a group of regular IVF patients to evaluate the impact of these treatments on quality of life, as measured by FERTQOL. Thus, this study aims to understand the quality of life of women undergoing in vitro fertilisation treatment, with an emphasis on oocyte donors and recipient patients.

Materials and Methods

Study population

This prospective cross-sectional study was conducted with infertile women undergoing assisted reproduction treatment. Participants were recruited from an assisted reproduction clinic and selected according to inclusion and exclusion criteria. Women undergoing in vitro fertilisation (IVF) treatment were selected, regardless of the number of previous treatments. Sixty women with infertility participated in the study and were classified into the following groups:

Group 1: 15 oocyte recipients;

Group 2: 19 egg donors;

Group 3: 26 women undergoing treatment, neither donors nor recipients (control group).

The data were collected between November 2023 and March 2025. Data collection began after approval by the Ethics and Research Committee, under number AGHUse: 2022 - 0569 and number CAAE: 68406022.5.0000.5327. In addition, all participants signed a free and informed consent form.

Procedures

The patients were seen by the psychologist and, during the appointment, were invited to participate in the study. This consultation usually takes place before the start of treatment, and attendance can be via online or in-person. If accepted, after reading and signing the informed consent form, the sociodemographic questionnaire was administered together with the FERTIQOL. All included patients from groups 1 and 2 were in the anonymous modality.

Questionnaires

FERTIQOL is a questionnaire with 24 (twenty-four) questions, scored from 0 (zero) to 100 (one hundred) points, which assesses the quality of life in people with fertility problems, with higher scores indicating better QoL. The results are divided into four domains: mind-body, emotional, relational, and social. The mind-body domain encompasses physical and cognitive health, while the emotional domain addresses the impact on emotional

health. The relational domain encompasses assessing the relationship with the partner and social issues related to the environment (Boivin et al., 2011b). The FERTIQOL questionnaire uses a 5-point Likert scale for scoring, with scores ranging from 0 to 100; higher scores indicate better quality of life.

The sociodemographic questionnaire includes variables such as age, education, and employment status, as well as treatment status and number of previous pregnancies.

Sample size calculation

To detect a 15-point difference in FertiQoL scores, assuming a score of 75 in the control group and 60 in the study group, a sample size of 16 women per group was required (Pocock, 1983).

Statistical analysis

The collected data were stored in Excel and subsequently exported to the JASP program for analysis. Three main statistical models were used to perform the analyses:

One-way ANOVA (Analysis of Variance): This model was used to compare whether there were significant differences in the mean total FERTIQOL score among the three treatment groups (TREATMENT TYPE: Recipients, Donors, and IVF with own oocytes). **Tukey's Post-hoc Test:** After the ANOVA confirmed an overall difference, this test was applied to perform pairwise comparisons. It allowed, for example, the identification that the IVF with its own oocyte group had a significantly lower quality of life than the Donors and Recipients groups, while the latter two did not show a significant difference between them. **Binary Logistic Regression:** This model was used to calculate Odds Ratios (OR). For this purpose, the continuous variable "Quality of Life" was transformed into a binary variable (0 = Normal Quality of Life; 1 = Low Quality of Life, defined by cut-off points < 80 or < 70). The regression made it possible to estimate the risk associated with variables such as: Treatment type (especially Type 3 – IVF with own oocytes), psychotropic medication, months of attempts and age. We consider the level of significance ($p < 5\%$) statistically relevant for our data comparison.

Results

According to the study, Table 1 shows that the average age (mean $\pm$ SD) of women undergoing treatment varies by subgroup. Donor oocyte patients were younger (30 $\pm$ 3) than recipients (41 $\pm$ 5) or regular IVF patients (36 $\pm$ 4), $p<0.001$.

According to the marital status variable, no significant differences were found between the groups in treatment type ($p=0.288$). The three groups showed a predominance of married couples, accounting for 90% of couples across the groups (Table 1).

Similarly, religion did not show significant results across the treatment types ($p = 0.349$). In Table 1, the religion with the highest prevalence was Catholicism, at 60% of women, followed by Evangelicalism at 18% and Spiritism at 6%.

Regarding education, women with a completed higher education degree had the highest level of education, accounting for 78% in the three groups. A completed high school education ranked second at 11%. The group with the lowest level of education was group 2, comprising egg donors. During treatment, 85% of women were employed, and all groups showed similar results (Table 1).

Table 2 presents some selected obstetric outcomes from the included patients. The most relevant data is about the number of previous treatments. As expected, the group of oocyte recipients showed more prior treatments than the other groups ($p<0.001$)

As for the results obtained through the FERTIQOL questionnaire, using ANOVA, for the type of treatment and the mind/body domain, there is a significant difference among the three groups ($p<0.001$). Group 2, the donors, had the highest mean score (93.64 $\pm$ 5.61), indicating a better score in this domain. In addition, there was no significant difference compared to group 1, which had a mean score of (87.77 $\pm$ 12.05). While group 3 had the lowest mean (72.27 $\pm$ 16.37), indicating poorer quality of life in the mind/body domain, as shown in Table 3.

In the emotional domain, there are also statistically significant differences between the groups, as indicated by the analysis ($p<0.001$). As shown in Table 3, once again, group 3, corresponding to women who did not undergo egg donation, had the lowest mean of

66.98±19.10 and showed a significant difference relative to groups 1 and 2, which had means of 81.77±12.05 and 86.79±9.6, respectively.

Also, in Table 3, the analysis of variance (ANOVA) indicated a statistically significant difference between the groups for the relational aspect ($p=0.040$). The descriptive means showed that group 1 (mean 94.99±5.93) and group 2 (mean 95.83±8.56) had similar results, whereas group 3 (mean 84.92±21.89) had a worse relationship with their partner during treatment.

Moreover, regarding the social aspect, a significant difference was observed among the groups ($p=0.018$). The greatest differences in mean values occurred between group 1 and group 3. Group 1 had a mean of 82.22±15.38, group 2 had a mean of 77.41±18.65, and group 3 had a mean of 67.30±15.78 (Table 3), indicating fragility in the support network and difficulty in interpersonal relationships, especially among women undergoing treatment without egg donation (control group).

Regarding the total score, it is important to emphasise that, as observed in the previously mentioned aspects, Group 3 presented the lowest mean score (72.87 ± 12.43), whereas Group 1, with a mean of 86.73 ± 9.26 , and Group 2, with a mean of 88.73 ± 7.84 , showed similar mean values with no significant difference between them. According to the ANOVA and post hoc analysis, the control group, consisting of women undergoing in vitro fertilisation treatment without donating or receiving oocytes, had a significantly lower quality of life ($p < 0.001$) compared with the other two groups (Table 3).

Furthermore, in Table 4, we described the use of psychotropic drugs and psychotherapy, 20% of women undergoing treatment use medication, with a value of $p = 0.549$. In psychotherapy, 38% of women are undergoing treatment, and all groups showed similar results, with group 1 at 33%, group 2 at 31%, and group 3 at 46%.

Moreover, to identify the risk of a patient having a Total FertiQoL score below 70 (critical score), based on the following characteristics: treatment type, use of psychotropic medication, number of attempts, and age, a regression analysis and an Odds Ratio (OR) were performed. Through this analysis, it was observed that women undergoing IVF without donating or receiving oocytes had a 17 times greater chance of having a low quality of life compared with donors and recipients (Table 5). This result was controlled for patients' age, attempt time for fertility treatment and the use of psychotropic medication.

Discussion

Infertility is a condition that affects couples both physically and emotionally. Understanding this phenomenon, this study was conducted to assess the quality of life of women undergoing treatment, with a primary focus on egg donors and recipients. As we demonstrated, women who are undergoing treatment without donating or receiving eggs are those who demonstrate the lowest quality of life in the emotional sphere. This may be related to feelings of incapacity, low self-esteem, and high levels of anxiety and depression (Moutzouroulia et al, 2025), which are perceived from the diagnosis of infertility and throughout treatment.

During assisted reproduction treatment, couples experience different emotions, and this can lead to changes in their relationship, both negative and positive. Some studies indicate difficulties in the couple's relationship during this process, especially from a sexual point of view, where they mention that sexual intercourse becomes mechanical and a fulfilment of marital duties. Many treatments even include scheduled sexual intercourse, which turns the couple's intimate moments into an obligatory act, potentially leading to conflict (Batista et al, 2016).

On the other hand, couples also show greater strengthening of their relationship and improved communication when their peers are involved in treatment (Batista et al., 2016). In our study, the results corroborate the literature, as the relational domain shows high scores among donors and recipients. Furthermore, among the domains presented in FERTIQOL, the relational average has the highest scores.

Couples who have difficulty conceiving a child perceive themselves as failures from a social standpoint, leading to feelings of inferiority in relation to those who have children. In addition, they also feel ashamed and tend toward social isolation (Peterson et al., 2025). Given the results obtained in the social domain, we can see that this domain was the one that had the greatest negative impact on the quality of life of women undergoing assisted reproduction treatment, with the lowest scores in all three groups.

As in other domains, the group of women who neither donated nor received eggs also had a lower average score in the social domain. One study showed that people who share

their infertility with others have fewer depressive symptoms and emphasise how important social support is, while those who do not share their infertility have a greater sense of hopelessness about the future (Peterson et al, 2025).

Infertility and assisted reproduction treatment have significant consequences for couples experiencing this reality. According to a qualitative study conducted in the Midwest region of Brazil, repeated failed attempts to conceive diminish the couple's well-being and quality of life. The authors reveal that women undergoing treatment show feelings of guilt, in addition to experiencing difficulties in social relationships, due to the pressure to have a child (Batista et al., 2016).

Quality of life is a broad concept that aims to understand the well-being of each individual. QoL is influenced by physical, emotional, spiritual, relational, and social aspects (Bueno-Sanchez et al, 2024). The total FERTIQOL score represents all the domains already presented, such as mind/body, emotional, relational, and social. Consistent with the previous results, the group of women undergoing treatment without donating or receiving eggs also had a lower total FERTIQOL score than the group of donors and recipients.

In addition to changes in quality of life, women with infertility experience feelings of discrimination and judgment from others. Receiving a diagnosis of infertility is often associated with a grieving process, due to the loss of the possibility of conceiving a child naturally. These events lead to feelings of worthlessness, sadness, and increased anxiety in these women (Vieira & Junior, 2023).

To cope with the complexity of treatment, one of the coping strategies used by couples is spirituality and religiosity (Naab et al, 2025). In addition, to deal with fertility issues more healthily, it is also important to seek health support during assisted reproduction treatment, such as psychotherapy, support groups, and sometimes psychiatric support, as this time can involve negative feelings, resulting in high levels of anxiety and depression symptoms (Yan et al., 2024).

A study conducted on the use of psychotropic medication among women seeking assisted reproduction treatments indicates an increased risk of anxiety disorders, and a considerable number of them use psychotropic medicine (Carvalho et al., 2021). In the

present study, the control group had the highest rate of women using psychotropic drugs and undergoing psychotherapy. In addition, we observed that psychotherapy is still the strategy most commonly used by women undergoing assisted reproduction treatment to cope with adverse emotional symptoms.

Another important point to mention is the favourable results for the quality of life of donors and recipients. A study conducted with this group, which aimed to understand these women's motivation, concluded that their behaviour and feelings were extremely positive. Also, it is important to emphasise that donors' main motivation is to help other women altruistically (Oppenheimer et al., 2018). Therefore, for recipients, receiving an indication for treatment with donated eggs may initially cause fear and surprise, intensifying the impossibility of using their own oocytes. These women usually experience a grieving process for what they had idealised. With acceptance, a feeling of hope begins to prevail in these women (Montagnini et al., 2023).

A favourable aspect of this study is that the results are divided into donor, recipient, and control subgroups, providing a better understanding of the specific profiles of these women and their quality of life. However, the main limitation of this study is that it examines only heterosexual couples. This data may have some impact because, although female same-sex couples need assisted reproduction procedures to achieve pregnancy, they do not always have other factors contributing to infertility, and often do not perceive themselves as infertile. Another important issue is that we do not include patients using a familiar or oocyte bank model of oocyte donation. These patients may respond differently in terms of quality of life during fertility treatment.

In conclusion, patients submitted to regular IVF (non-donors or oocyte recipients) are at extreme risk for a decreased quality of life and consequently an increased psychotropic administration. We should better recognise and treat these patients during their fertility journey, increasing their well-being and performing a more comprehensive and patient-centred reproductive care.

References

- Batista LAT, Bretones WHD, Almeida RJ. O impacto da infertilidade: narrativas de mulheres com sucessivas negativas pelo tratamento de reprodução assistida. *Reprod Climat* 2016;31:121–127. <https://doi.org/10.1016/j.recli.2016.05.004>
- Bueno-Sánchez L, Alhambra-Borrás T, Gallego-Valadés A, Garcés-Ferrer J. Psychosocial impact of infertility diagnosis and conformity to gender norms on quality of life in infertile Spanish couples. *Int J Environ Res Public Health* 2024;21:158. <https://doi.org/10.3390/ijerph21020158>
- Carvalho CF, Mattia MMC, da Silva H, Bredemeier FGFS, Arpini NE, Chapon R, Fleck MPA, Cunha-Filho JS. Psychotropic medication use among women seeking assisted reproductive technology therapy: a cross-sectional study. *J Affect Disord* 2021;292:386–390. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2021.05.063>
- Celda-Belinchón L, **et al.** Quality of life in women and men with infertility: a cross-sectional study. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol* 2024;313:114649.
- Cousineau TM, Domar AD. Psychological impact of infertility. *Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol* 2007;21:293–308. <https://doi.org/10.1016/j.bpobgyn.2006.12.003>
- Madero S, Gameiro S, García D, Cirera D, Vassena R, Rodríguez A. Quality of life, anxiety and depression of German, Italian and French couples undergoing cross-border oocyte donation in Spain. *Hum Reprod* 2017;32:1862–1870. <https://doi.org/10.1093/humrep/dex247>
- Montagnini H, Malerbi F, Cedenho A. Ovodoação: a questão do sigilo. *Estud Psicol (Campinas)* 2012;29:239–246. <https://doi.org/10.1590/S0103-166X2012000200009>
- Montagnini HL, Kimati CT, Lorenzon AR, Bonetti TC, Serafini PC, Motta E, Domingues TS. Psycho-emotional acceptance in couple and single women who choose to undergo IVF treatment with donor eggs. *JBRA Assist Reprod* 2023;27:259–266. <https://doi.org/10.5935/1518-0557.20220036>
- Moutzouroulia A, Asimakopoulou Z, Tzavara C, Asimakopoulos K, Adonakis G, Kaponis A. The impact of infertility on the mental health of women undergoing in vitro fertilization treatment. *Sex Reprod Healthc* 2025;43:101072. <https://doi.org/10.1016/j.srhc.2025.101072>

Naab F, van der Wath AE, Kyei JM, **et al.** Spirituality as a coping strategy for infertility: a scoping review. *J Relig Health* 2025;64:2813–2831. <https://doi.org/10.1007/s10943-025-02302-w>

Oppenheimer D, Oppenheimer AR, Vilhena ST, Atzingen ACV. Shared egg donation: ideas and expectations in a bioethical context based on a qualitative study of Brazilian women. *Rev Bras Ginecol Obstet* 2018;40:527–533. <https://doi.org/10.1055/s-0038-1672160>

Peterson B, Taubman-Ben-Ari O, Chiu B, **et al.** Infertility stigma and openness with others are associated with depressive symptoms and meaning in life among men and women diagnosed with infertility. *Reprod Health* 2025;22:7. <https://doi.org/10.1186/s12978-025-01951-0>

Pocock SJ. *Clinical Trials: A Practical Approach*. Chichester: Wiley; 1983.

Trindade VD, Farinati D, Vasconcelos NF, Dornelles VC, Badalotti-Teloken I, Abur S, **et al.** Emotional impact and psychological aspects involving treatments with donated oocytes. *JBRA Assist Reprod* 2025;29:418–423. <https://doi.org/10.5935/1518-0557.20250008>

World Health Organization. Infertility. Geneva: WHO; 2020.

Yan Y, Ma Y, Xu L, **et al.** Impact of perceived social support on anxiety and depression in women undergoing in vitro fertilization–embryo transfer: the role of psychological resilience. *J Assist Reprod Genet* 2025;42:231–242. <https://doi.org/10.1007/s10815-024-03308-1>

Table 1. Demographic characteristics

Variable	Group 1 Oocyte recipient n=15	Group 2 Oocyte donor n=19	Group 3 Control n=26	p value
Age (Years)	40.86±5.1	30.42±3.1	36±4.7	<0.001*
Marital Status				0.288†
- Single	13%	5%	11%	0.151†
- Married	86%	94%	88%	
Educational level				0.211†
- Elementary School	-	5%	-	
- High School	6%	21%	7%	
- Undergraduate	-	15%	3%	
- Graduate	93%	57%	84%	
- Postgraduate	-	-	3%	
Work activity	80%	84%	88%	0.760†
Religion				0.349†
- No religion	6%	15%	7%	
- Catholic	66%	42%	69%	
- Evangelical	6%	31%	15%	
- Spiritist	13%	10%	-	
- Muslim	-	-	3%	
- Umbanda	6%	-	3%	

*Anova test

†Chi-square test

Table 2. History of pregnancies and treatments

Variable	Group 1 Oocyte recipient n=15	Group 2 Oocyte donor n=19	Group 3 Control n=26	p value
Prior treatments	60%	5%	19%	<0.001†
Children	20%	5%	11%	0.413†
Abortion	6%	5%	23%	0.151†

† Chi-square test

Table 3. FERTIQOL results in the groups

Domain (M±SD)	Group 1 Oocyte recipient n=15	Group 2 Oocyte donor n=19	Group 3 Control n=26	p value
Total Score	86.73±9.26	88.73±7.84	72.87±12.43	<0.001*
Emotional	81.77±12.05	86.79±9.60	66.98±19.10	<0.001*
Mind-body	87.77±11.29	93.64±5.61	72.27±16.37	<0.001*
Relational	94.99±5.93	95.83±8.56	84.92±21.89	0.040*
Social	82.22±15.38	77.41±18.65	67.30±15.79	0.018*

*ANOVA test

Table 4. Mental health care history

Variable	Group 1 Oocyte recipient n=15	Group 2 Oocyte donor n=19	Group 3 Control n=26	p value
Psychoterapy	33%	31%	46%	0.549†
Psychotropic medication	6%	10%	34%	0.045†

† Chi-square test

Table 5. Logistic regression analysis of factors associated with the outcome

Variable	Odds Ratio (OR)	95%CI	p value
IVF with Own Oocytes (Control)	17.47	3.12 - 97.80	< 0.001
Psychotropic medication	1.71	0.38 - 7.65	0.48
Attempts > 24 months	1.14	0.28 - 4.58	0.85
Age (> 35 years)	1.50	0.39 - 5.72	0.55

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante dos achados da literatura, a maioria dos estudos que comparam a qualidade de vida entre homens e mulheres inférteis relata que as mulheres apresentam maior sofrimento emocional e menor qualidade de vida. Considerando isso, o presente estudo quis dedicar-se a compreender melhor a qualidade de vida de mulheres em tratamento de reprodução assistida, FIV, com foco em compreender melhor as doadoras, receptoras e as mulheres em tratamento sem doar ou receber óvulos.

Esse estudo foi motivado a analisar se há menor qualidade de vida entre as receptoras e as doadoras em relação às demais mulheres em tratamento; porém, surpreendentemente, os achados demonstram que as mulheres que mais apresentam prejuízos na qualidade de vida são justamente as que não doam ou recebem óvulos.

É importante ressaltar que geralmente as receptoras de óvulos já estão tentando ter filhos a mais tempo e já tiveram inúmeras tentativas de tratamento anteriores, gerando maior experiência e conhecimento acerca do assunto.

As mulheres que estão em tratamento sem doar ou receber apresentam maior número de gestações interrompidas e conseqüentemente buscam mais por atendimento em saúde mental, como acompanhamento psicológico e psiquiátrico, justamente por apresentar um sofrimento emocional mais intenso. Por isso, faz-se necessário o acompanhamento em saúde mental durante o tratamento de reprodução assistida.

9. PERSPECTIVA

Esse estudo abre oportunidades para que outros estudos específicos com doadoras e receptoras possam se tornar mais recorrentes na literatura para que possamos ter maior entendimento desses grupos. Além disso, seriam importantes estudos complementares que investiguem estratégias de enfrentamento e resiliência, tanto nas mulheres em tratamento sem doar ou receber, quanto nas doadoras e receptoras.

Outra questão relevante é, a partir dos resultados obtidos neste estudo, poder estruturar novas intervenções psicológicas com as mulheres em tratamento de reprodução assistida, proporcionando maior acolhimento emocional durante esse período.

10. ANEXOS

10.1 ANEXO 1 - Termo de consentimento livre e esclarecido

Número CAAE: 68406022.5.0000.5327

Título do Projeto: ***“Qualidade de vida em mulheres doadoras e receptoras de oócitos submetidas a Fertilização in vitro”.***

Gostaríamos de convidá-los a participar de uma pesquisa cujo objetivo principal é verificar se há diferença na qualidade de vida de mulheres inférteis, que vão realizar ovodação, que serão receptoras e as que estão realizando tratamento, sem doar ou receber óvulo. Este estudo pretende verificar se existe diminuição da qualidade de vida em função da infertilidade e se há diferença entre mulheres que doam e recebem óvulos, comparadas a mulheres inférteis.

Se você aceitar participar da pesquisa será convidada (o) a responder os seguintes instrumentos:

- Questionário sobre qualidade de vida, que possui 24 questões (FERTIQOL).
- Questionário Sociodemográfico. O tempo necessário para responder os instrumentos é de cerca de 20 minutos.

O seu tratamento de fertilização in vitro não será modificado pelo fato de participar deste estudo.

Os possíveis desconfortos decorrentes da participação na pesquisa são em função do conteúdo das perguntas, que envolvem aspectos de sua intimidade.

Os possíveis benefícios são de estar em contato com profissional sobre um tema importante que, muitas vezes, é negligenciado. E, além disso, compreender e contribuir para o aumento de conhecimento no tema em questão.

Sua participação na pesquisa é totalmente voluntária, ou seja, não é obrigatória. Caso você decida não participar, ou ainda, desistir de participar e retirar seu consentimento, não haverá nenhum prejuízo ao atendimento que você recebe ou possa vir a receber na instituição.

Não está previsto nenhum tipo de pagamento pela sua participação na pesquisa e você não terá nenhum custo envolvido.

Os dados coletados durante a pesquisa serão sempre tratados confidencialmente. Os resultados serão apresentados de forma conjunta, sem a identificação dos participantes, ou seja, o seu nome não aparecerá na publicação dos resultados.

Caso você tenha dúvidas, poderá entrar em contato com o pesquisador responsável Prof. Dr. João Sabino Lahorgue da Cunha Filho – Professor e Pesquisador do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia – Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), com a pesquisadora Camila Oliveira de Souza, ou com o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), pelo telefone (51) 33596246, ou através do endereço, Av. Protásio Alves, 211 - Portão 4 - 5º andar do Bloco C - Rio Branco - Porto Alegre/RS, de segunda à sexta, das 8h às 17h.

Permanecerá com vocês uma cópia deste termo de consentimento e a equipe dessa pesquisa estará à disposição para qualquer esclarecimento.

Eu, _____, RG: _____, fui informada dos objetivos especificados acima e da justificativa desta pesquisa, de forma clara e detalhada. Todas as minhas dúvidas foram respondidas com clareza e sei que poderei solicitar novos esclarecimentos a qualquer momento. Além disto, sei que novas informações, obtidas durante o estudo, me serão fornecidas e terei liberdade de retirar meu consentimento de participação na pesquisa em qualquer momento.

ASSINATURA da PACIENTE: _____

NOME DO PESQUISADOR QUE APLICOU O TERMO: _____

Porto Alegre, ____ de _____ de 20 ____.

PESQUISADOR: Psicóloga Camila Oliveira de Souza – Programa de Pós-graduação em Ginecologia e Obstetrícia - UFRGS

PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Prof. Dr. João Sabino Lahorgue da Cunha Filho – Professor e Pesquisador do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia – Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA)

TELEFONE PARA CONTATO E DÚVIDAS: 51- 3359-8117 – Serviço de Ginecologia e Obstetrícia – HCPA

COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA - HCPA: (51) 33596246, e-mail cep@hcpa.edu.br

10.2 ANEXO 2 - FERTIQOL

FertiQoL International

Questionário sobre Fertilidade e Qualidade de Vida (2008)

Para cada pergunta, assinale por favor (com um ✓) a resposta que melhor reflecte a forma como pensa e se sente. Responda com base no que pensa e no que sente actualmente.

Algumas perguntas podem dizer respeito à sua vida privada, mas são necessárias para avaliar adequadamente todos os aspectos da sua vida.

Preencha por favor os itens assinalados com um asterisco (*) apenas se tiver um(a) companheiro(a).

	Para cada pergunta, assinale a resposta que mais se aproxima dos seus pensamentos e sentimentos actuais	Muito má	Má	Nem boa nem má	Boa	Muito boa
A	Como avaliaria a sua saúde?	☐	☐	☐	☐	☐
	Para cada pergunta, assinale a resposta que mais se aproxima dos seus pensamentos e sentimentos actuais	Muito insatisfeito(a)	Insatisfeito(a)	Nem satisf. nem insatisfeito(a)	Satisfeito(a)	Muito satisfeito(a)
B	Está satisfeito(a) com a sua qualidade de vida?	☐	☐	☐	☐	☐
	Assinale com um visto (✓) a resposta que melhor define o que pensa e sente actualmente	Completamente	Muito	Mais ou menos	Pouco	Nada
Q1	A sua atenção e concentração são prejudicadas por pensamentos de infertilidade?	☐	☐	☐	☐	☐
Q2	Acha que não consegue avançar com outros objectivos e planos de vida por causa dos problemas de fertilidade?	☐	☐	☐	☐	☐
Q3	Sente-se esgotado(a) ou exausto(a) por causa dos problemas de fertilidade?	☐	☐	☐	☐	☐
Q4	Sente que é capaz de lidar com os seus problemas de fertilidade?	☐	☐	☐	☐	☐
	Para cada pergunta, assinale a resposta que mais se aproxima dos seus pensamentos e sentimentos actuais	Muito insatisfeito(a)	Insatisfeito(a)	Nem satisf. nem insatisfeito(a)	Satisfeito(a)	Muito satisfeito(a)
Q5	Está satisfeito(a) com o apoio que recebe de amigos relativamente aos seus problemas de fertilidade?	☐	☐	☐	☐	☐
*Q6	Está satisfeito(a) com a sua vida sexual, apesar de ter problemas de fertilidade?	☐	☐	☐	☐	☐
	Para cada pergunta, assinale a resposta que mais se aproxima dos seus pensamentos e sentimentos actuais	Sempre	Muitas vezes	Às vezes	Raramente	Nunca
Q7	Os seus problemas de fertilidade dão origem a sentimentos de ciúme e rancor?	☐	☐	☐	☐	☐
Q8	Costuma ter sentimentos de angústia e/ou de perda por não conseguir ter um filho (ou mais filhos)?	☐	☐	☐	☐	☐
Q9	Sente que oscila entre a esperança e o desespero por causa dos problemas de fertilidade?	☐	☐	☐	☐	☐
Q10	Encontra-se socialmente isolado(a) por causa dos problemas de fertilidade?	☐	☐	☐	☐	☐
*Q11	É afectuoso(a) com o(a) seu(sua) companheiro(a) e ele(ea) consigo apesar dos seus problemas de fertilidade?	☐	☐	☐	☐	☐
Q12	Os seus problemas de fertilidade interferem com o seu trabalho ou as suas obrigações do dia-a-dia?	☐	☐	☐	☐	☐
Q13	Sente-se desconfortável ao participar em situações sociais, tais como férias e festas, por causa dos seus problemas de fertilidade?	☐	☐	☐	☐	☐
Q14	Sente que a sua família consegue compreender aquilo por que está a passar?	☐	☐	☐	☐	☐
	Para cada pergunta, assinale a resposta que mais se aproxima dos seus pensamentos e sentimentos actuais	Muitíssimo	Muito	Mais ou menos	Pouco	Nada
*Q15	O facto de ter problemas de fertilidade fortaleceu a sua dedicação ao seu companheiro(a)?	☐	☐	☐	☐	☐
Q16	Sente-se triste e deprimido(a) em relação aos seus problemas de fertilidade?	☐	☐	☐	☐	☐
Q17	Os seus problemas de fertilidade tomam-no inferior às pessoas com filhos?	☐	☐	☐	☐	☐
Q18	Sente-se fatigado(a) devido a problemas de fertilidade?	☐	☐	☐	☐	☐
*Q19	Os problemas de fertilidade tiveram um impacto negativo na sua relação?	☐	☐	☐	☐	☐
*Q20	Sente dificuldade em falar com o(a) seu(sua) companheiro(a) sobre o que sente relativamente à infertilidade?	☐	☐	☐	☐	☐
*Q21	Está satisfeito(a) com a sua relação, apesar de ter problemas de fertilidade?	☐	☐	☐	☐	☐
Q22	Sente pressão social para ter (ou ter mais) filhos?	☐	☐	☐	☐	☐
Q23	Os seus problemas de fertilidade deixam-no irritado?	☐	☐	☐	☐	☐
Q24	Sente dor e desconforto físico por causa dos seus problemas de fertilidade?	☐	☐	☐	☐	☐

10.3 ANEXO 3 - Questionário sociodemográfico

Data da aplicação:

- 1) Nome:
- 2) Idade:
- 3) Estado civil: ☐ solteira
☐ casada
☐ união estável
☐ viúva
- 4) Religião:
- 5) Escolaridade:
- 6) Profissão:
- 7) Trabalha no momento? ☐ Sim ☐ Não
- 8) Cidade:
- 9) Com quem reside?
- 10) Filhos: ☐ sim ☐ não Se sim, quantos? _____
- 11) Já teve gestações interrompidas?
- 12) Qual o motivo da infertilidade?
- 13) Quantos anos de tentativas?
- 14) Já realizou tratamentos de reprodução assistida anteriormente?
Quantos?
- 15) Psicoterapia? ☐ Sim ☐ Não
- 16) Psicofármaco? ☐ Sim ☐ Não